



PEDOMAN KOMPILASI DATA HASIL SKRINING PENYAKIT TIDAK MENULAR (PTM) PROGRAM KAMPUNG CERDIK



KATA PENGANTAR

Upaya promotif dan preventif sangat efektif untuk mencegah meningkatnya kematian dan kesakitan akibat penyakit tidak menular (PTM). Mengingat pencegahan penyakit akan sangat tergantung pada perilaku individu yang didukung oleh kualitas lingkungan, ketersediaan sarana dan prasarana serta dukungan regulasi untuk hidup sehat, diperlukan keterlibatan aktif seluruh komponen baik pemerintah pusat dan daerah, sektor non-pemerintah, dan masyarakat. Untuk mengubah mindset dan pola hidup masyarakat agar menerapkan gaya hidup sehat agar terhindar dari berbagai penyakit terutama penyakit tidak menular (PTM) yang sebagian besar disebabkan karena pola hidup yang tidak sehat Dinas Kesehatan menginisiasi inovasi Kampung Cerdik. Kampung Cerdik merupakan salah satu upaya penguatan program pengendalian penyakit tidak menular yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan deteksi dini faktor resiko PTM sebagai upaya mewujudkan keluarga yang sehat dan berkualitas di wilayah minimal setingkat dusun atau rukun warga. Kata “CERDIK” dalam Kampung Cerdik merupakan singkatan dari Cek kesehatan secara rutin, Enyahkan asap rokok, Rajin beraktivitas, Diet seimbang, Istirahat cukup dan Kelola stress. Kampung cerdas tidak hanya melakukan skrining saja tapi juga pengobatan untuk hipertensi dan diabetes. Untuk orang yang di skrining PTM dan terdeteksi menderita penyakit hipertensi dan diabetes maka akan diberikan gelang penanda.

Dengan adanya pedoman ini sebagai panduan kegiatan inovasi Kampung Cerdik di Dinas Kesehatan dapat dimanfaatkan sebagai upaya peningkatan upaya kesehatan promotif dan preventif.

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANYUWANGI

AMIR HIDAYAT, SKM, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I.....	4
PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Tujuan.....	5
1.3 Ruang Lingkup.....	5
1.4 Variabel yang Dikumpulkan.....	5
1.5 Indikator yang Dihasilkan.....	6
1.6 Proses Bisnis Kompilasi Data Hasil Skrining Penyakit Tidak Menular (PTM) Program Kampung Cerdik Kabupaten Banyuwangi.....	7
1.7 Instrumen yang Digunakan.....	8
1.8 Jadwal Kegiatan Kompilasi Data Hasil Skrining Penyakit Tidak Menular (PTM) Program Kampung Cerdik Kabupaten Banyuwangi.....	8
1.9 Sistematika Penulisan Buku Pedoman Kompilasi Data.....	9
BAB II.....	10
TIM PROGRAM KAMPUNG CERDIK.....	10
2.1 Kriteria dan Tugas Kader Posbindu Penyakit Tidak Menular (PTM).....	10
2.2 Peran Para Pihak Kegiatan Kompilasi Data Hasil Skrining Penyakit Tidak Menular (PTM) Program Kampung Cerdik Kabupaten Banyuwangi.....	10
BAB III.....	13
MEKANISME PELAKSANAAN.....	13
BAB IV.....	14
KONSEP DAN DEFINISI.....	14
LAMPIRAN.....	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Kabupaten Banyuwangi, orang dengan usia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar mencapai 771.658 (54,53%) dari target 1.011.588. Pelayanan pada penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dari target 348.480 hanya mencapai 477.570 atau 76,46%. Pelayanan pada penderita DM usia ≥ 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dari target 41.964 hanya tercapai 28.869 atau 68,79%.

Upaya promotif dan preventif sangat efektif untuk mencegah meningkatnya kematian dan kesakitan akibat penyakit tidak menular (PTM). Mengingat pencegahan penyakit akan sangat tergantung pada perilaku individu yang didukung oleh kualitas lingkungan, ketersediaan sarana dan prasarana serta dukungan regulasi untuk hidup sehat, diperlukan keterlibatan aktif seluruh komponen baik pemerintah pusat dan daerah, sektor non-pemerintah, dan masyarakat. Untuk mengubah mindset dan pola hidup masyarakat agar menerapkan gaya hidup sehat agar terhindar dari berbagai penyakit terutama penyakit tidak menular (PTM) yang sebagian besar disebabkan karena pola hidup yang tidak sehat Dinas Kesehatan menginisiasi inovasi Kampung Cerdik. Kampung Cerdik merupakan salah satu upaya penguatan program pengendalian penyakit tidak menular yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat dalam memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan.

Peraturan Bupati No 26 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Penyakit Tidak Menular Melalui Kampung Cerdik Menimbang Bahwa Penyakit Tidak Menular Menjadi Masalah Kesehatan Masyarakat Sehingga Perlu Dilakukan Penyelenggaraan Penanggulangan Terhadap Penyakit Tidak Menular Melalui Pencegahan, Pengendalian Dan Penanganan Yang Komprehensif, Efisien, Efektif Dan Berkelanjutan.

Meningkatkan kualitas hidup penderita PTM terutama penderita diabetes dan hipertensi melalui pemberian gelang setelah skrining serta peningkatan kepedulian pada warga dan pasien untuk memantau kesehatannya dan penderita hipertensi dan diabetes yang telah diberikan gelang skrining.

I.2 Tujuan

Tujuan dari Program KAMPUNG CERDIK antara lain:

- a. Melindungi masyarakat dari resiko penyakit tidak menular;
- b. Meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi dampak sosial, budaya dan ekonomi akibat penyakit tidak menular pada individu, keluarga dan masyarakat;
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat untuk mencegah faktor resiko penyakit tidak menular.

I.3 Ruang Lingkup

Kompilasi Data Hasil Skrining Penyakit Tidak Menular (PTM) Program Kampung Cerdik Di Kabupaten Banyuwangi 2024 dilaksanakan dalam frekuensi bulanan dan mencakup wilayah kerja desa di Kabupaten Banyuwangi.

I.4 Variabel yang Dikumpulkan

Variabel yang dikumpulkan pada Kompilasi Data Hasil Skrining Penyakit Tidak Menular (PTM) Program Kampung Cerdik Di Kabupaten Banyuwangi 2024 adalah sebagai berikut:

I.4.1 Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia yang tercantum di beberapa dokumen kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, dan sumber lainnya. NIK terdiri dari 16 digit angka yang mengandung informasi kependudukan seseorang.

I.4.2 Nama Orang

Panggilan lengkap seseorang sesuai dengan nama yang tercantum pada kartu keluarga (KK) atau kartu tanda penduduk (KTP).

I.4.3 Jenis Kelamin

Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki.

I.4.4 Tanggal Lahir

Waktu (tanggal, bulan, tahun) dimana seseorang lahir.

I.4.5 Wilayah Provinsi

Nama wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah provinsi.

I.4.6 Kabupaten/Kota

Nama wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum.

I.4.7 Kecamatan

Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris Daerah.

I.4.8 Desa/Kelurahan

Nama wilayah yang dipimpin oleh kepala desa/kepala kelurahan (lurah) yang berada di bawah koordinasi camat.

I.4.9 RT/RW

Satuan lingkungan terkecil.

I.4.10 Tinggi Badan

Ukuran panjang badan.

I.4.11 Berat Badan

Besarnya ukuran bobot badan.

I.4.12 Lingkar Perut

Keliling bulatan perut.

I.4.13 Tekanan Darah

Tekanan yang ditimbulkan pada dinding arteri ketika jantung memompa darah ke seluruh tubuh.

I.4.14 Gula Darah

Kadar glukosa darah yang merupakan sumber energi utama bagi tubuh dan berasal dari makanan yang dikonsumsi.

I.5 Indikator yang Dihasilkan

Indikator yang dihasilkan pada Kompilasi Data Hasil Skrining Penyakit Tidak Menular (PTM) Program Kampung Cerdik Di Kabupaten Banyuwangi 2024 adalah Jumlah Peserta Skrining Penyakit

Tidak Menular (PTM). Jumlah Peserta Skrining Penyakit Tidak Menular merupakan Banyaknya orang yang telah melakukan pemeriksaan Penyakit Tidak Menular (PTM). Indikator tersebut dihasilkan dengan level estimasi kabupaten dengan satuan orang dan klasifikasi penyajian berupa wilayah.

1.6 Proses Bisnis Kompilasi Data Hasil Skrining Penyakit Tidak Menular (PTM) Program Kampung Cerdik Kabupaten Banyuwangi

Proses bisnis Kompilasi Data Hasil Skrining Penyakit Tidak Menular (PTM) Program Kampung Cerdik Kabupaten Banyuwangi 2024 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan

- a. Desain Kegiatan (Perancangan) meliputi aktivitas pengajuan rekomendasi dan standar data, merancang output, merancang konsep dan definisi variabel, merancang pengumpulan data, merancang kerangka sampel, merancang metode pengambilan sampel, merancang pengolahan dan analisis, dan merancang sistem alur kerja. Dalam hal ini, kegiatan Kompilasi Data Hasil Skrining Penyakit Tidak Menular (PTM) Program Kampung Cerdik Kabupaten Banyuwangi 2024 dilakukan secara berulang dengan frekuensi penyelenggaraan bulanan. Metode pengumpulan datanya yaitu pengumpulan data sekunder dengan unit pengumpulan data berupa individu. Selain itu, sarana pengumpulan datanya adalah *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI), serta Kompilasi data dari aplikasi.

2. Pengumpulan

Pengumpulan data hasil skrining Penyakit Tidak Menular (PTM) di Kabupaten Banyuwangi yang berasal dari website ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku) dapat dilakukan melalui serangkaian proses yang terstruktur. Awalnya, data skrining PTM seperti tekanan darah, gula darah, tinggi badan, berat badan, dan lingkar perut diperoleh secara tahunan dari platform ASIK yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan. Data ini biasanya bersifat agregat dan belum terperinci per waktu atau wilayah administratif terkecil. Untuk memenuhi kebutuhan monitoring dan evaluasi secara lebih berkala di tingkat daerah, data tahunan tersebut kemudian diekstrak, dibersihkan, dan diklasifikasikan ulang berdasarkan wilayah kerja Puskesmas, kecamatan, hingga desa atau kelurahan. Selanjutnya, melalui koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas, data tersebut diolah dan direkapitulasi menjadi laporan bulanan. Proses ini melibatkan pemisahan data berdasarkan indikator skrining dan waktu pelayanan, sehingga memungkinkan analisis tren dan cakupan layanan skrining PTM secara

lebih akurat dan periodik. Hasil akhir dari proses ini digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan kesehatan preventif di Kabupaten Banyuwangi.

3. Pemeriksaan

- a. Pengolahan Data merupakan proses bisnis statistik yang meliputi integrasi data, penyuntingan (*editing* dan imputasi), melakukan estimasi dan agregat, dan lain sebagainya. Dalam Kompilasi Data Hasil Skrining Penyakit Tidak Menular (PTM) Program Kampung Cerdik Kabupaten Banyuwangi 2024 dilakukan pengolahan data antara lain penyuntingan (*editing*), *data entry*, dan penyahihan (validasi).
- b. Analisis pada Kompilasi Data Hasil Skrining Penyakit Tidak Menular (PTM) Program Kampung Cerdik Kabupaten Banyuwangi 2024 dilakukan dengan metode analisis deskriptif dengan unit analisis individu, serta tingkat penyajian hasil analisis adalah kabupaten.

4. Penyebarluasan

- a. Diseminasi Hasil meliputi aktivitas sinkronisasi antara data dengan metadata, menghasilkan produk diseminasi, manajemen rilis produk diseminasi, mempromosikan produk diseminasi, dan manajemen *user support*. Produk diseminasi dari Kompilasi Data Hasil Skrining Penyakit Tidak Menular (PTM) Program Kampung Cerdik Kabupaten Banyuwangi 2024 tersedia untuk umum dalam bentuk digital (*softcopy*).
- b. Evaluasi meliputi aktivitas berupa mengumpulkan masukan evaluasi dan evaluasi hasil.

1.7 Instrumen yang Digunakan

Dokumen atau Instrumen yang digunakan dalam Kompilasi Data Hasil Skrining Penyakit Tidak Menular (PTM) Program Kampung Cerdik Kabupaten Banyuwangi 2024 sebagai berikut:

No.	Jenis Instrumen	Kegunaan
1.	Formulir Skrining PTM (manual atau digital)	Untuk mencatat hasil pemeriksaan fisik (tekanan darah, tinggi badan, berat badan, lingkar perut, gula darah) secara individu. Bisa berupa lembar isian di Puskesmas/Posbindu atau aplikasi digital seperti ASIK.
2.	Aplikasi ASIK (Sehat Indonesiaku)	Digunakan oleh tenaga kesehatan untuk langsung memasukkan data hasil pemeriksaan ke sistem pusat.
3.	Timbangan Digital dan Alat Ukur Tinggi Badan	Untuk mendapatkan data akurat tentang berat dan tinggi badan.

No.	Jenis Instrumen	Kegunaan
4.	Pengukur Lingkar Perut (Meteran Medis)	Untuk mengukur lingkar perut sesuai standar skrining PTM.
5.	Tensimeter Digital atau Manual	Untuk mengukur tekanan darah.
6.	Glucometer (Alat Tes Gula Darah)	Untuk mengukur kadar gula darah sewaktu.
7.	Dashboard Visualisasi	Menyajikan data secara visual untuk pemantauan oleh pengambil kebijakan.

**I.8 Jadwal Kegiatan Kompilasi Data Hasil Skrining Penyakit Tidak Menular (PTM)
Program Kampung Cerdik Kabupaten Banyuwangi**

KEGIATAN		JADWAL
A. Perencanaan		
1.	Perencanaan Kegiatan	01 - 05 Desember 2024
2.	Desain	02 - 04 Desember 2024
B. Pengumpulan		
3.	Pengumpulan Data	05 - 29 Desember 2024
C. Pemeriksaan		
4.	Pengolahan Data	29 - 30 Desember 2024
5.	Analisis	30 - 31 Desember 2024
D. Penyebarluasan		
6.	Diseminasi Hasil	01 - 05 Januari 2024
7.	Evaluasi	06 - 09 Januari 2024

BAB II

TIM PROGRAM KAMPUNG CERDIK

2.1 Kriteria dan Tugas Kader Posbindu Penyakit Tidak Menular (PTM)

No.	Peran	Kriteria dan Tugas
1.	Koordinator	Ketua dari perkumpulan dan penanggungjawab kegiatan serta berkoordinasi terhadap Puskesmas dan Para Pembina terkait di wilayahnya.
2.	Kader Penggerak	Anggota perkumpulan yang aktif, berpengaruh dan komunikatif bertugas menggerakkan masyarakat, sekaligus melakukan wawancara dalam penggalan informasi.
3.	Kader Pemantau	Anggota perkumpulan yang aktif dan komunikatif bertugas melakukan pengukuran Faktor Risiko PTM.
4.	Kader Konselor / Edukator	Anggota perkumpulan yang aktif, komunikatif dan telah menjadi panutan dalam penerapan gaya hidup sehat, bertugas melakukan konseling, edukasi, motivasi serta menindaklanjuti rujukan dari Puskesmas.
5.	Kader Pencatat	Anggota perkumpulan yang aktif dan komunikatif bertugas melakukan pencatatan hasil kegiatan Posbindu PTM dan melaporkan kepada koordinator Posbindu PTM

2.2 Peran Para Pihak Kegiatan Kompilasi Data Hasil Skrining Penyakit Tidak Menular (PTM) Program Kampung Cerdik Kabupaten Banyuwangi

2.2.1 Kader Posbindu PTM

Dari sejumlah kader yang telah dilatih ditetapkan Koordinator dan Penanggung Jawab untuk Penggerak, Pemantau, Konselor/Edukator serta Pencatat. Tugas yang dilakukan oleh kader adalah sebagai berikut :

01. Pada H-I, Tahap persiapan :

- Mengadakan pertemuan kelompok untuk menentukan jadwal kegiatan.
- Menyiapkan tempat dan peralatan yang diperlukan.
- Membuat dan menyebarkan pengumuman mengenai waktu pelaksanaan

02. Pada hari H, Tahap Pelaksanaan :

- Melakukan pelayanan dengan sistem 5 meja atau modifikasi sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama.
- Aktivitas bersama seperti olahraga bersama, demo masak, penyuluhan, konseling, sarasehan atau peningkatan keterampilan bagi para anggotanya termasuk rujukan ke Puskesmas/klinik swasta/RS.

03. Pada H+ I, Tahap Evaluasi

- Menilai kehadiran (para anggotanya, kader dan undangan lainnya).
- Mengisi catatan pelaksanaan kegiatan.
- Mengidentifikasi masalah yang dihadapi.
- Mencatat hasil penyelesaian masalah.
- Melakukan tindak lanjut berupa kunjungan rumah bila diperlukan.
- Melakukan konsultasi teknis dengan Pembina Posbindu PTM.

2.2.2 Petugas Kesehatan Puskesmas

Puskesmas memiliki tanggung jawab pembinaan Posbindu PTM di wilayah kerjanya sehingga kehadiran petugas kesehatan puskesmas dalam kegiatan Posbindu PTM sangat diperlukan dalam wujud peran:

01. Memberikan bimbingan teknis kepada para kader Posbindu PTM dalam penyelenggaraannya.
02. Memberikan materi kesehatan terkait dengan permasalahan faktor resiko PTM dalam penyuluhan maupun kegiatan lainnya.
03. Mengambil dan menganalisa hasil kegiatan Posbindu PTM.
04. Menerima, menangani dan member umpan balik kasus rujukan dari Posbindu PTM.
05. Melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan lain terkait.

2.2.3 Para Pemangku Kepentingan

01. Camat

Mengoordinasikan hasil kegiatan dan tindak lanjut Posbindu PTM di wilayah kerjanya selaku penanggung jawab wilayah kecamatan serta melakukan pembinaan dalam mendukung kelestarian kegiatan Posbindu PTM.

02. Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain

Mengoordinasikan hasil kegiatan dan tindak lanjut Posbindu PTM di wilayah kerjanya selaku penanggung jawab wilayah desa/kelurahan serta melakukan pembinaan dalam mendukung kelestarian Posbindu PTM.

03. Para pimpinan Kelompok/lembaga/instansi/organisasi

Mendukung dan berperan aktif dalam kegiatan Posbindu PTM sesuai dengan minat dan misi kelompok/lembaga/instansi/organisasi kelompok tersebut.

04. Tokoh/Penggerak Masyarakat

Menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dan mendukung dengan sumber daya yang dimiliki terhadap penyelenggaraan Posbindu PTM.

05. Dunia Usaha

Mendukung penyelenggaraan Posbindu PTM dalam bentuk sarana dan pembiayaan termasuk berperan aktif sebagai sukarelawan sosial.

BAB III

MEKANISME PELAKSANAAN



BAB IV

KONSEP DAN DEFINISI

No	Nama Variabel (Karakteristik)	Konsep	Definisi
1	NIK	Nomor Induk Kependudukan (NIK)	Nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia yang tercantum di beberapa dokumen kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, dan sumber lainnya. NIK terdiri dari 16 digit angka yang mengandung informasi kependudukan seseorang.
2	Nama	Nama Orang	Panggilan lengkap seseorang sesuai dengan nama yang tercantum pada kartu keluarga (KK) atau kartu tanda penduduk (KTP)
3	Jenis Kelamin	Jenis Kelamin	Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki.
4	Tanggal Lahir	Tanggal Lahir	Waktu (tanggal, bulan, tahun) dimana seseorang lahir
5	Provinsi	Wilayah Provinsi	Nama wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah provinsi.
6	Kabupaten / Kota	Kabupaten / Kota	Nama wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum.
7	Kecamatan	Kecamatan	Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris Daerah.
8	Desa/Kelurahan	Desa/ Kelurahan	Nama wilayah yang dipimpin oleh kepala desa/kepala kelurahan (lurah) yang berada di bawah koordinasi camat.
9	RT/RW	RT/ RW	Satuan lingkungan terkecil
10	Tinggi badan	Tinggi Badan	Ukuran panjang badan
11	Berat badan	Berat Badan	Besarnya ukuran bobot badan
12	Lingkar perut	Lingkar Perut	Keliling bulatan perut

No	Nama Variabel (Karakteristik)	Konsep	Definisi
13	Tekanan Darah	Tekanan Darah	Tekanan yang ditimbulkan pada dinding arteri ketika jantung memompa darah ke seluruh tubuh
14	Gula Darah	Gula Darah	Kadar glukosa darah yang merupakan sumber energi utama bagi tubuh dan berasal dari makanan yang dikonsumsi



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 26 TAHUN 2020
TENTANG
PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR MELALUI KAMPUNG CERDIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia;

b. bahwa penyakit tidak menular menjadi masalah kesehatan masyarakat karena menimbulkan rasa sakit, cacat dan kematian yang tinggi, serta menimbulkan beban pembiayaan kesehatan sehingga perlu dilakukan penyelenggaraan penanggulangan terhadap penyakit tidak menular melalui pencegahan, pengendalian dan penanganan yang komprehensif, efisien, efektif, dan berkelanjutan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Penyakit Tidak Menular Melalui Kampung CERDIK.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor $\frac{188/MENKES/PB/1/2011}{\text{Nomor 7 Tahun 2011}}$ tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1775);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Layanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kawasan Terbatas Merokok (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 21 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 21);

14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 44), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 59 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 59).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN PENYAKIT
TIDAK MENULAR MELALUI KAMPUNG CERDIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi- tingginya di wilayah kerjanya.
8. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
9. Kader Kesehatan adalah anggota masyarakat yang membantu melaksanakan pembangunan kesehatan di Desa/Kelurahan secara sukarela.

10. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya;
11. Penyakit Tidak Menular yang selanjutnya disebut PTM adalah penyakit yang tidak bisa ditularkan dari orang ke orang, yang perkembangannya berjalan perlahan dalam jangka waktu yang panjang (kronis).
12. Penanggulangan PTM adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif serta paliatif yang ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian yang dilaksanakan secara komprehensif, efektif, efisien dan berkelanjutan.
13. Pos Binaan Terpadu Penyakit Tidak Menular yang selanjutnya disingkat Posbindu PTM merupakan peran serta masyarakat dalam melakukan kegiatan deteksi dini dan pemantauan faktor resiko PTM meliputi merokok, konsumsi minuman beralkohol, pola makan tidak sehat, kurang aktivitas fisik, obesitas, stres, hipertensi, hiperglikemi, hiperkolesterol serta menindaklanjuti secara dini faktor resiko yang ditemukan melalui konseling kesehatan dan segera merujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang dilaksanakan secara terpadu, rutin dan periodik.
14. Kawasan Terbatas Merokok adalah area yang dinyatakan terbatas untuk kegiatan penggunaan rokok.
15. Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di kawasan terbatas merokok.
16. CERDIK adalah slogan kesehatan yang setiap hurufnya memiliki makna yaitu Cek kesehatan secara berkala, Enyahkan asap rokok, Rajin aktivitas fisik, Diet dengan kalori seimbang, Istirahat cukup dan Kelola stress.
17. Kampung adalah suatu daerah dimana terdapat beberapa rumah atau keluarga yang bertempat tinggal disana (minimal 1 rukun warga)
18. Kampung CERDIK adalah salah satu upaya penguatan program pengendalian penyakit tidak menular yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan deteksi dini faktor resiko PTM sebagai upaya mewujudkan keluarga yang sehat dan berkualitas di wilayah minimal setingkat dusun atau rukun warga.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pengendalian penyakit tidak menular melalui Kampung CERDIK bertujuan untuk :

- a. melindungi masyarakat dari resiko penyakit tidak menular;
- b. meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi dampak sosial, budaya dan ekonomi akibat penyakit tidak menular pada individu, keluarga dan masyarakat;
- c. meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat untuk mencegah faktor resiko penyakit tidak menular.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Pengendalian penyakit tidak menular;
- b. Sasaran pengendalian penyakit tidak menular melalui Kampung CERDIK;
- c. Pembentukan dan pengembangan Kampung CERDIK;
- d. Pembinaan dan pengawasan;
- e. Pembiayaan.

BAB IV PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR

Bagian Kesatu

Pengendalian Penyakit Tidak Menular Melalui Kampung CERDIK

Pasal 4

- (1) Pengendalian penyakit tidak menular melalui Kampung CERDIK dilaksanakan melalui upaya:
 - a. deteksi dini dan monitoring PTM melalui kegiatan Posbindu PTM;
 - b. menerapkan Kawasan Terbatas Merokok (KTM);
 - c. melaksanakan kegiatan senam rutin bersama masyarakat;
 - d. mensosialisasikan gaya pola hidup sehat melalui diet dengan kalori seimbang, istirahat cukup dan mengelola stres dengan baik.
- (2) Mekanisme Pengendalian Penyakit Tidak Menular melalui Kampung CERDIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Kegiatan deteksi dini yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengurangi resiko penyakit tidak menular dan komplikasinya.
- (2) Kegiatan deteksi dini penyakit tidak menular sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a dilaksanakan secara berkesinambungan dengan membentuk Posbindu PTM.

Pasal 6

- (1) Posbindu PTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan oleh :
 - a. kader Posbindu PTM yang bertugas setiap bulan dengan sasaran pemeriksaan masyarakat usia 15 tahun ke atas sesuai hasil kesepakatan yang berada di wilayah kerjanya; dan
 - b. petugas kesehatan/petugas puskesmas yang bertugas setiap bulan dengan target pemeriksaan 80% dari sasaran (masyarakat usia 15 tahun ke atas)
- (2) Kegiatan yang dilakukan oleh kader Posbindu PTM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a adalah :
 - a. melakukan wawancara faktor resiko PTM;
 - b. memeriksa setiap peserta Posbindu PTM meliputi tinggi badan, berat badan, lingkar perut, tekanan darah, gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, analisa gula darah dan rujukan apabila ada kelainan.
 - c. memberikan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat.
 - d. melaporkan hasil pemeriksaan dan pemantauan kepada puskesmas setempat.
- (3) Kegiatan kader Posbindu PTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada buku petunjuk teknis pembinaan pelaksanaan Posbindu PTM dari Kementerian Kesehatan.

Pasal 7

Petugas Kesehatan Puskesmas melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Posbindu PTM di Kampung CERDIK.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat Dalam Pengendalian Penyakit Tidak Menular Melalui
Kampung CERDIK

Pasal 8

- (1) Masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok berperan aktif dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular melalui Kampung CERDIK.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) dengan membentuk dan mengembangkan Posbindu PTM, menyediakan tempat khusus untuk merokok dan berperan aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan penerapan pola hidup sehat dan turut serta mendukung pelaksanaan segala kegiatan di Kampung CERDIK.
- (3) Pada Posbindu PTM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan kegiatan deteksi dini, monitoring dan tindak lanjut dini faktor resiko PTM secara mandiri dan berkesinambungan di bawah pembinaan Puskesmas.
- (4) Setelah dilakukan skrining kesehatan di Posbindu PTM, masyarakat akan mendapatkan kartu Skrining Kesehatan Posbindu PTM yang dapat digunakan sebagai salah satu persyaratan pengurusan surat menyurat di tingkat Rukun Tetangga/Rukun Warga.

BAB V

SASARAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR MELALUI
KAMPUNG CERDIK

Pasal 9

- (1) Pengendalian penyakit tidak menular melalui Kampung CERDIK dilaksanakan di semua desa/kelurahan di Kabupaten secara bertahap di tingkat Kampung/Dusun/Rukun Warga
- (2) Sasaran utama dalam program Kampung CERDIK adalah kelompok masyarakat sehat, beresiko dan penyandang PTM berusia 15 tahun ke atas

BAB VI PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN KAMPUNG CERDIK

Bagian Kesatu

Pembentukan Kampung CERDIK

Pasal 10

- (1) Kampung CERDIK dibentuk untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat Kampung/Dusun/Rukun Warga melalui kegiatan pengendalian penyakit tidak menular yaitu Posbindu PTM, Kawasan Terbatas Merokok dan penerapan pola hidup sehat.
- (2) Pembentukan Kampung CERDIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Pengembangan wilayah Kampung CERDIK di tingkat Desa/Kelurahan dapat dikembangkan dari 1 (satu) Dusun/RW ke Dusun/RW lainnya.

Bagian Kedua

Pembinaan Kampung CERDIK

Pasal 11

- (1) Guna menunjang fasilitasi/koordinasi pengembangan Kampung CERDIK di Kabupaten dibentuk Tim Koordinasi Pengembangan Kampung CERDIK Kabupaten.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah sebagai berikut :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Anggota.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketuai oleh Dinas yang membidangi dan beranggotakan Kepala Perangkat Daerah lintas sektor.
- (4) Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah membuat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan Kampung CERDIK.
- (5) Tugas Ketua Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah memimpin dan mengoordinasikan pengembangan Kampung CERDIK di Kabupaten.

- (6) Tugas Wakil Ketua Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah.
- (7) Tugas Sekretaris Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam mengoordinasikan pengembangan Kampung CERDIK di Kabupaten serta mempersiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat Tim dan mengoordinir pelaksanaan rapat Tim secara berkala.
- (8) Tugas Anggota Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah memberikan masukan dan informasi kepada Ketua Tim melalui Wakil Ketua terkait pengembangan Kampung CERDIK di Kabupaten serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim maupun Wakil Ketua Tim.
- (9) Guna kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Sekretariat Tim yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur terkait sesuai kebutuhan.
- (10) Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (9) ditetapkan oleh Bupati.
- (11) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala.

Bagian Ketiga

Tim Koordinasi Pengembangan Kampung CERDIK Kecamatan

Pasal 12

- (1) Guna optimalisasi pelaksanaan pengendalian penyakit tidak menular melalui Kampung CERDIK, selain Tim Koordinasi Pengembangan Kampung CERDIK Kabupaten, dibentuk pula Tim Koordinasi Pengembangan Kampung CERDIK Kecamatan.
- (2) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung CERDIK Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Camat.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah sebagai berikut :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Anggota.

- (4) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung CERDIK Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Camat, Wakil Ketua dijabat oleh Sekretaris Camat, Sekretaris Dijabat oleh Lurah/Kepala Desa, dan beranggotakan Kepala Unit Pelaksana Teknis.
- (5) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung CERDIK Kecamatan bertugas melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Kampung CERDIK di Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan.
- (6) Ketentuan mengenai tugas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim Koordinasi Pengembangan Kampung CERDIK Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) berlaku secara mutatis mutandis terhadap tugas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim Koordinasi Pengembangan Kampung CERDIK Kecamatan.
- (7) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung CERDIK Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Tim Koordinasi Pengembangan Kampung CERDIK Kabupaten secara berkala dengan tembusan kepada SKPD terkait.

Bagian Keempat

Langkah – Langkah Pembentukan Kampung CERDIK

Pasal 13

- (1) Langkah–langkah Pembentukan Kampung CERDIK ialah sebagai berikut :
 - a. Perencanaan Program dan kegiatan Kampung CERDIK;
 - b. Tahapan pembentukan Kampung CERDIK;
 - c. Pembentukan Tim Kampung CERDIK;
 - d. Pencanaan Kampung CERDIK.
- (2) Perencanaan Program dan kegiatan Kampung CERDIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Kepala Puskesmas di wilayahnya melalui forum masyarakat (RT,RW,Tokoh Agama/Adat) dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. sosialisasi pembentukan Kampung CERDIK;
 - b. pelatihan kader Posbindu PTM;
 - c. penyusunan rencana program dan kegiatan Kampung CERDIK sesuai indikator – indikator keberhasilan yang telah ditetapkan;

- d. kajian kebutuhan dan pemetaan alur pengalokasian anggaran kegiatan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Alokasi Dana Desa;
 - e. penyusunan rincian anggaran biaya dan kerangka acuan kegiatan.
- (3) Tahapan pembentukan Kampung CERDIK diinisiasi oleh Dinas, kecamatan, Kepala Puskesmas dan pemerintah desa/kelurahan melalui tahapan sebagai berikut :
- a. Tahapan di Kabupaten
 - 1. Bupati, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lembaga/Institusi mitra kerja Dinas, Camat, Kepala Desa, Kepala Kelurahan, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemerintahan Masyarakat Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Kader Posbindu PTM, Dokter dan Bidan Desa berkomitmen dan mendukung seluruh rangkaian kegiatan dari mulai proses pembentukannya, operasionalisasi kesehatan sampai dengan evaluasi dan pelaporan.
 - 2. Penyusunan profil wilayah-wilayah yang akan ditetapkan sebagai Kampung CERDIK di Kabupaten, berisi :
 - a) Luas dan letak geografis wilayah kampung yang akan diusulkan menjadi Kampung CERDIK;
 - b) Data demografi wilayah Kampung CERDIK antara lain jumlah penduduk (per kelompok umur), jumlah kepala keluarga dan tingkat pendidikan;
 - c) Data Potensi Desa/Kelurahan, yaitu data sarana dan prasarana Desa/Kelurahan, meliputi :
 - 1) Jalan;
 - 2) Klinik;
 - 3) Puskesmas;
 - 4) Sekolah;
 - 5) Kelompok usaha ekonomi;
 - 6) Rumah Sehat;
 - 7) Sumber Daya Alam.

3. Proses penetapan wilayah sebagai Kampung CERDIK melalui tahapan:
 - a) Rapat penetapan wilayah Kampung CERDIK dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pengembangan Kampung CERDIK Kabupaten dan Tim Koordinasi Pengembangan Kampung CERDIK Kecamatan yang akan ditetapkan menjadi Kampung CERDIK;
 - b) Penetapan wilayah Kampung CERDIK oleh Camat.
- b. Tahapan di Desa/Kelurahan
 1. Identifikasi dan penetapan kader sebagai penggerak dan fasilitator Kampung CERDIK oleh Kepala Desa/Kelurahan;
 2. Pertemuan warga dalam rangka sosialisasi dan membangun kesepahaman tentang Kampung CERDIK;
 3. Identifikasi dan analisa masalah di wilayah Kampung CERDIK;
 4. Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya;

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 14

Pembinaan penyelenggaraan Kampung CERDIK dilaksanakan oleh Dinas dengan berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan institusi terkait lainnya.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 15

Pengawasan terhadap penyelenggaraan Kampung CERDIK dilakukan secara bertingkat sebagai berikut :

- a. Tingkat kabupaten oleh Dinas;
- b. Tingkat kecamatan oleh Puskesmas; dan
- c. Tingkat desa/kelurahan oleh bidan penanggung jawab wilayahnya bersama kader Posbindu PTM.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan penyelenggaraan pengendalian penyakit tidak menular melalui Kampung CERDIK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 3 April 2020
BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 3 April 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

Ttd.

H. MUJIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2020 NOMOR 26

MEKANISME PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR MELALUI
KAMPUNG CERDIK

1. Pendahuluan

Penyakit Tidak Menular (PTM) adalah penyebab kematian terbanyak di Indonesia. Keadaan dimana penyakit tidak menular masih menjadi masalah kesehatan penting dan dalam waktu bersamaan morbiditas (angka kesakitan) dan mortalitas (angka kematian) PTM makin meningkat merupakan beban ganda dalam pelayanan kesehatan dan menjadi tantangan yang harus dihadapi dalam pembangunan bidang kesehatan di Indonesia.

Peningkatan prevalensi penyakit tidak menular menjadi ancaman yang serius dalam pembangunan, karena mengancam pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, Kabupaten berinovasi dalam mengendalikan PTM melalui Kampung CERDIK. Kampung CERDIK merupakan salah satu langkah preventif dan promotif yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat agar terhindar dari faktor resiko PTM. CERDIK merupakan slogan kesehatan yang setiap hurufnya mempunyai makna yaitu, C adalah Cek kesehatan secara berkala, E adalah Enyahkan asap rokok, R adalah Rajin aktivitas fisik, D adalah Diet sehat dengan kalori seimbang, I adalah Istirahat cukup dan K adalah Kelola stres.

2. Indikator

Indikator Pengendalian Penyakit Tidak Menular Melalui Kampung CERDIK yaitu sebagai berikut :

1. Setiap keluarga berpartisipasi aktif memeriksakan kesehatannya secara rutin ke Posbindu meliputi :
 - a. cek kesehatan Faktor Resiko PTM (pengukuran obesitas, tekanan darah, kadar gula darah)
 - b. deteksi dini gangguan mental emosional;
 - c. Wanita usia subur di skrining/deteksi kanker serviks dengan metode IVA/papsmear
2. Seluruh anggota keluarga bebas asap rokok

3. Menyediakan tempat khusus untuk merokok di lingkungan

Kampung CERDIK dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok yang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik
 - b. terpisah dari gedung/rumah/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas
 - c. jauh dari tempat orang berlalu lalang/beraktivitas.
4. Melakukan aktivitas fisik/senam bersama yang dilakukan minimal 1 bulan sekali
 5. Anggota keluarga mengkonsumsi sayur dan buah
 6. Keluarga aktif dalam kegiatan sosial
 7. Penderita hipertensi berobat secara teratur
 8. Penderita DM berobat secara teratur

3. Pelaksanaan Posbindu PTM

a. Waktu Penyelenggaraan

Posbindu PTM dapat diselenggarakan dalam sebulan sekali, bila diperlukan dapat lebih dari satu kali dalam sebulan untuk kegiatan pengendalian faktor resiko PTM lainnya, misalnya olahraga bersama, sarasehan dan lainnya. Hari dan waktu yang dipilih sesuai dengan kesepakatan serta dapat saja disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat.

b. Tempat

Tempat pelaksanaan sebaiknya berada di lokasi yang mudah dijangkau dan nyaman bagi peserta. Posbindu PTM dapat dilaksanakan di salah satu rumah warga, balai desa/kelurahan, salah satu kios pasar, salah satu ruang perkantoran/klinik perusahaan, ruangan khusus di sekolah, salah satu ruangan di dalam lingkungan tempat ibadah, atau tempat tertentu yang disediakan oleh masyarakat secara swadaya.

c. Pelaksanaan Kegiatan

Posbindu PTM dilaksanakan dengan 5 tahapan layanan yang disebut sistem 5 meja, namun dalam situasi kondisi tertentu dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama. Kegiatan tersebut berupa pelayanan deteksi dini dan tindak lanjut sederhana serta monitoring terhadap faktor resiko penyakit tidak menular, termasuk rujukan ke Puskesmas. Dalam pelaksanaannya pada setiap langkah secara sederhana dapat diuraikan sebagai berikut;



Pembagian peran kader Posbindu PTM idealnya sebagai berikut, namun sebaiknya setiap kader memahami semua peranan tersebut, pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kesepakatan.

No	Peran	Kriteria dan Tugas
1	Koordinator	Ketua dari perkumpulan dan penanggungjawab kegiatan serta berkoordinasi terhadap Puskesmas dan Para Pembina terkait di wilayahnya.
2	Kader Penggerak	Anggota perkumpulan yang aktif, berpengaruh dan komunikatif bertugas menggerakkan masyarakat, sekaligus melakukan wawancara dalam penggalan informasi.

3	Kader Pemantau	Anggota perkumpulan yang aktif dan komunikatif bertugas melakukan pengukuran Faktor Resiko PTM
4	Kader konselor/Edukator	Anggota perkumpulan yang aktif, komunikatif dan telah menjadi panutan dalam penerapan gaya hidup sehat, bertugas melakukan konseling, edukasi, motivasi serta menindaklanjuti rujukan dari Puskesmas
5	Kader Pencatat	Anggota perkumpulan yang aktif dan komunikatif bertugas melakukan pencatatan hasil kegiatan Posbindu PTM dan melaporkan kepada koordinator Posbindu PTM

d. Peran Para Pihak

I. Kader Posbindu PTM

Dari sejumlah kader yang telah dilatih ditetapkan Koordinator dan Penanggung Jawab untuk Penggerak, Pemantau, Konselor/Edukator serta Pencatat. Tugas yang dilakukan oleh kader adalah sebagai berikut :

- i. Pada H-1, Tahap persiapan :
 - Mengadakan pertemuan kelompok untuk menentukan jadwal kegiatan
 - Menyiapkan tempat dan peralatan yang diperlukan
 - Membuat dan menyebarkan pengumuman mengenai waktu pelaksanaan
- ii. Pada hari H, Tahap Pelaksanaan :
 - Melakukan pelayanan dengan sistem 5 meja atau modifikasi sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama
 - Aktivitas bersama seperti olahraga bersama, demo masak, penyuluhan, konseling, sarasehan atau peningkatan ketrampilan bagi para anggotanya termasuk rujukan ke Puskesmas/klinik swasta/RS.

iii. Pada H+1, Tahap Evaluasi

- Menilai kehadiran (para anggotanya, kader dan undangan lainnya)
- Mengisi catatan pelaksanaan kegiatan
- Mengidentifikasi masalah yang dihadapi
- Mencatat hasil penyelesaian masalah
- Melakukan tindak lanjut berupa kunjungan rumah bila diperlukan
- Melakukan konsultasi teknis dengan Pembina Posbindu PTM

II. Petugas Kesehatan Puskesmas

Puskesmas memiliki tanggung jawab pembinaan Posbindu PTM di wilayah kerjanya sehingga kehadiran petugas kesehatan puskesmas dalam kegiatan Posbindu PTM sangat diperlukan dalam wujud peran:

- i. Memberikan bimbingan teknis kepada para kader Posbindu PTM dalam penyelenggaraannya
- ii. Memberikan materi kesehatan terkait dengan permasalahan faktor resiko PTM dalam penyuluhan maupun kegiatan lainnya
- iii. Mengambil dan menganalisa hasil kegiatan Posbindu PTM
- iv. Menerima, menangani dan member umpan balik kasus rujukan dari Posbindu PTM
- v. Melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan lain terkait

III. Para Pemangku Kepentingan

i. Camat

Mengoordinasikan hasil kegiatan dan tindak lanjut Posbindu PTM di wilayah kerjanya selaku penanggung jawab wilayah kecamatan serta melakukan pembinaan dalam mendukung kelestarian kegiatan Posbindu PTM

ii. Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain

Mengoordinasikan hasil kegiatan dan tindak lanjut Posbindu PTM di wilayah kerjanya selaku penanggung jawab wilayah desa/kelurahan serta melakukan pembinaan dalam mendukung kelestarian Posbindu PTM

- iii. Para pimpinan Kelompok/lembaga/instansi/organisasi
Mendukung dan berperan aktif dalam kegiatan Posbindu PTM sesuai dengan minat dan misi kelompok/lembaga/instansi/organisasi kelompok tersebut
- iv. Tokoh/Penggerak Masyarakat
Menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dan mendukung dengan sumber daya yang dimiliki terhadap penyelenggaraan Posbindu PTM
- v. Dunia Usaha
Mendukung penyelenggaraan Posbindu PTM dalam bentuk sarana dan pembiayaan termasuk berperan aktif sebagai sukarelawan social

4. Pemberiaan Kartu CERDIK Berupa Kartu Skrining Kesehatan Posbindu PTM

Setelah dilakukan skrining kesehatan di Posbindu PTM, masyarakat akan mendapatkan kartu Skrining Kesehatan Posbindu PTM sebagai salah satu persyaratan pengurusan surat menyurat di tingkat Rukun Tetangga/Rukun Warga dan kartu berlaku 1 tahun sejak tanggal dilakukannya pemeriksaan.

KARTU SKRINING KESEHATAN
POSBINDU PTM

1. Riwayat Penyakit Tidak Menular

:

2. Faktor Risiko Asap Rokok

:

Ya / Tidak

3. Aktifitas Fisik - 150 menit/minggu

:

Ya / Tidak

4. Konsumsi Sayur & Buah 5 porsi/hari

:

Ya / Tidak

5. Berat Badan / Tinggi Badan

:

kg/cm; IMT :

6. Lingkar Perut

:

(P < 80 cm, L < 90 cm)

7. Tekanan Darah

:

mmHg (< 140/90 mmHg)

8. Pemeriksaan Mata

:

Kanan : / Kiri :

9. Pemeriksaan Telinga

:

Kanan : / Kiri :

10. Pemeriksaan Gula Darah Sewaktu

:

mg/dL (< 200 mg/dL)

11. Kolesterol total

:

mg/dL (< 200 mg/dL)

12. Gangguan Mental Emosional

:

Ya / Tidak (Ya lebih dari 6)

Lakukan Pemeriksaan Skrining Kesehatan kembali tanggal

- b. Gelang warna biru digunakan untuk penderita hiperglikemia (Diabetes mellitus)



BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS